EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	Nº EGRESO	:	87569
SERVICIO	:	MEDICINA HSC			
FECHA	:	2024-06-29 09:13:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: CARMEN GLORIA CONTRERAS SILVA			RUN	: 8.629.039-1
F.Nac	: 11-12-1960	Edad	: 63 AÑOS, 6 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: POB. V.HONDO PJE. 5 DE ABRIL 926			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA A	Teléfono	: 982217894		
Fecha Ingreso	: 2024-06-25	Fecha Egreso	: 2024-06-29 09:13:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18-NEUMONIA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

SDRA Resuelta.
NAC en vias de compensación
HTA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J15.9-NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J44-OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente Femenina Con Antecedentes De Hta Sistemica, Epoc En Tratamiento Regular Quien Refiere Inicio De Cuadro Clinico Hace 15 Dias Caracterizado Por Odinofagia, Tos Seca Y Malestar General Y Desde Hace 2 Dias Presenta Aumento Del Patron De Disnea Con Tos Productiva Por Lo Que Acude Al Su Hsc Donde Ingresa Disneica, Con Desaturacion Solicitan Laboratorios Iniciales Que Destaca Leucocitosis 21.800 Con Neutrofilia Y Pcr Moderadamente Alto , Con Dimero D Elevado Realizan Angiotac Torax Que Reporta (Examen Sin Evidencias De Tep, Voluminosa Condensacion En El Lobulo Inferior Izquierdo Con Areas De Cavitacion Centrales, Considerar Origen Inflamatorio Infeccioso, Severa Enfisema Y Cambios Inlamatorios De Via Aerea Intrapulmona) Por Lo Que Se Evalua Y Se Autoriza Ingreso.
Evolucionando Favorablemente, Hemodinamia Estable, Afebril, Sin Dolor, Con Buena Tolerancia A Alimentación Vo, Sin Episodios De Nauseas Y/O Vomitos, Sat O2 Fluctuante Entre 85-92%; , Con Persistencia De Apoyo Con O2 Suplementario Con Fio2 22%; Menos Disneica Acorde A Su Relato En Comparativa A Ayer, Panel Viral Acotado (-). Evaluado Con Upc En Contexto De Disnea, Sin Requerimiento Actual
Ex De Lab 26/06 -> Crea 0,4, Pcr 82,1; Bun 9, Uremia 20; Na/K/Cl 141/4,1/102; Gb 13,2; Hb/Hcto 11.6/35.4; Plaq 419000; Segment 81%; Vhs 32; Proca 0,11; Gsa Ph 7,46; Pco2 53,6; Po2 64,2; Hco3 38,2
Para El Dia De Hoy Sin Requerimiento De Oxígeno Suplementario, , Sin Disnea, Sat 89% Fio2 21%, Normocardica, Normotensa, Diuresis Positiva, Deposiciones Positivas.
Tórax Hipoexpansible Mp Presente Disminuido En Basa, Con Crepitos Finos Dispersos. Rr2ts.
En condiciones de alta médica con HODOM.

PLAN DE MANEJO:

Continuar tto HODOM
Continuar tto crónico
Control sos Urgencias.

INDICACIONES AL ALTA

1. Regimen Hiposodico Liviano A Tolerancia
2. Bromuro De Ipratropio 4 Puff C/6hrs Por Ac
3. Salmeterol 2 Puff C/12 Hrs Por Ac
4. Trelegy 2 Puff Al Dia
5. Knt Respiratoria Dos Veces Al Dia
6. Hidrocortisona 100 Mg Dia Por 3 Dias Ev
7. Ceftriaxona Frasco 2 Gramo Cada 24 Hrs. Por 3 Dias Via Endovenosa
8. Azitromicina Comprimido 500 Milígramos 1 Comprimido Cada 24 Hrs. Por 1dias Via Oral
9. Losartan Potasico Comprimido 50 Miligramos 1 Comprimido Cada 12 Hrs.
10. Control sos Urgencia

EXÁMENES Y RESULTADOS

Creatinina : 0,40 * mg/dl
Clearence Calculado(MDRD) : 161,21
Lactato : 1,1
Proteina C Reactiva : 31,3
Uremia : 32
Sodio (Na) : 142,00 mmol/L

Potasio (K) : 3,70 mmol/L
Cloro (Cl) : 103,00
Hemoglobina : 12,0 g/dl
Hematocrito : 36,1 o/o
Recuento de leucocitos : 10,00 mil/ul
Recuento Hematies : 4,05 Mill/ul,20
pH : 7,43 7,35 - 7,45
pCO2 : 47,9 * mmHg
pO2 : 53,1 * mmHg
HCO3 ACT. : 32,1 * mmol/L
O2 SAT : 87,0

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO